Module 1 : Repères identitaires et socio-historique de la PA
Cours 2 : Contexte, ampleur et conséquences de la proche aidance

Objectifs

- Connaitre les différents éléments contextuels (historique, politique et social) entourant la proche aidance
- Connaitre l'ampleur (statistiques) du phénomène de la proche aidance au Québec.
- Identifier les conséquences (impacts positifs et négatifs) du rôle de personnes proches aidantes.
- Connaitre les politiques, lois et plans d'action qui réfèrent aux personnes proches aidantes.

PPT narré :

- 2 parties (12m18 + 17m02)

Lectures (12) :

- Lavoie, J-P et Guberman : Prendre soin des PA ayant des incapacités (2007) – p.76 à 86
- Infographie statistiques : 1 page d'info
- Infographie statistiques 2 : 1 page d'info

Contexte historique entourant la proche aidance au Québec

Changements dans les contextes d'aide (Ducharme, 2012) (éléments expliquant les chang.; avant vs ajd)

1. **Transformations des familles**
   - ***Avant*** les famille étaient nombreuses, facilitant l'attribution de l'aide à un membre de la famille. D'autant plus que les femmes ne travaillaient pas ou peu, une fois ses enfants élevés, elle pouvait s'occuper de ses parents âgés. Les femmes célibataires aussi étaient disponibles.
   - ***Aujourd'hui***, les parents ont moins d'enfants (1-2) et en raison des recompositions familiales, cet enfant peut se retrouver avec 4 parents (beau, belle).
2. **Mobilité géographique**
   - ***Aujourd'hui***, les familles sont dispersées dans la province/pays/ailleurs dans le monde.
   - Prendre soin lorsqu'on est loin de ses proches rend donc la tâche plus ardue (pas impossible, mais fortement difficile).
3. **Valeurs d'autoréalisation et de performance**
   - Une des raisons pour lesquelles on n'offre pas tjrs de l'aide à un membre de la famille (outre la distance et la composition des familles), c'est dû aux valeurs sociétales d'autoréalisation et performance.
   - ***Aujourd'hui,*** la société est telle que chacun s'organise avec ses affaires, montrer qu'il est fort/autonome/capable. On ne veut pas dépendre des autres, ni être un fardeau pour sa famille. On dévalorise le fait d'être interdépendant (vu négativement d'avoir ''besoin''), alors que l'entraide est dans nature humaine, c'est une question de survie.
4. **Valorisation de l'intimité à distance**
   - Les gens ne veulent pas être trop prêt pour conserver leur intimité. Ils aiment vivre seul.
   - Impact de cela durant la Covid, surtout pour les ainées, a été difficile. C'est plus facile de rester isolé en famille de 5, que seul chez soi. Exacerber si l'on a des problèmes d'autonomie ou dépendance, nécessitant l'aide d'autrui.

Ampleur du phénomène de la proche aidance au Québec

Statistiques

- **Intro :**
  - Les stats varient bcp, selon leur provenance.

    - Le gouv. et organismes prennent leur chiffre parfois au qc, au can, d'aidant s'occupant d'un ainé ou de plus de 15 ans… donc c'est normal que les chiffres changent.
    - La définition d'aidant varie.
    - Les études diffèrent entre elles, on ne compte pas les mm choses et ni de la mm manière.
    - Il faut reconnaître les limites des études, les questions posées et le contexte. Bref les chiffres doivent tjrs être expliqués.
    - Au qc, on a peu de stats sur le nbr de PA, car plusieurs ne se reconnaissent pas tel quel. (jeune de moins de 18 ans ou conjoint âgé)
- **Combien y a-t-il de PA au CAN-QC ?**
    - **25 %** des **Québécois et des Canadiens** sont proches aidants (Hango, 2020; Lecours, 2015), soit 1 étudiants sur 4 dans ce cour.
    - **46%** ou 13 millions de **canadiens** l'ont été au **cours de leur vie** (Sinha, 2012)
- **PA travailleurs :**
    - **55 % ont entre 45-64 ans, dont 56 % travaillent** (Lecours, 2015) ce qui a pour **impact de** :
        - Réduction du temps de travail
        - Perte de revenus personnel de 16 000$ / an (Fast, 2015)
- **Femmes proches aidantes :**
    - **54-59 %** (CSF, 2018; Lecours, 2015; Sinha, 2012) des femmes ont :
        - Plus de tâches, plus complexes et intenses
        - Subissent plus d'impacts (stress, épuisement, appauvrissement) (CSF, 2018)
    - **Pourquoi plus de femmes PA ?**
        - Espérance de vie plus élevé
        - Propension au don de soi plus grand
        - Taux de maladie dégénérative est moins élevé chez elles
        - *Post 65 ans, H=F, donc plus de différence
        - Donc les hommes vont plus être PA post retraite vs les femmes encore sur le marché du travail.
- **Temps alloué :**
    - Près de **24 %** des proches aidants y consacreraient **10 h et plus/sem**. (ISQ, 2012)
- **''Non''**
    - **40 %** n'auraient pas choisi d'assumer ce rôle (ISQ, 2014)
- **Tâches des PA :**
    - Transport, travaux domestiques, soins personnels, des traitements, des soins médicaux
- **Ce qu'implique les tâches des PA :**
    - **Transport :** est-ce 1x sem ou 3-4 fois pour recevoir des soins à l'hôpital
    - **Soins :** est-ce que c'est donner un bain 3x sem, couper ongles 1x mois ou changer une culotte 5x par jour
    - **Fréquence et intensité** sont 2 facteurs à considérer lorsqu'on parle de complexité de tâches.
- **Au Canada :**
    - Sans proche aidant, il faudrait embaucher **1,2 million de professionnels à temps complet** (Fast, 2015)
- **Au Québec :**
    - Valeur de l'apport des proches aidants : **4-10 milliards $/an** (Kempeneers, Battaglini et Van Pevenage, 2015)
    - L'aide à un proche dure en moyenne **6.5 années**.
    - Les proches aidants répondraient à **85 % des besoins des aidés au QC** (Kempeneers, Battaglini et Van Pevenage, 2015)

        - Ex. Au Qc, pour une personne ayant besoin de 22h de soins, le PA assure 18.7h et le CLSC 3.3h
    - **C'est un mythe de dire qu'au Qc on ne s'occupe pas des aînées et qu'on les place dans les résidences.**
        - Une chance que les familles sont là, car le réseau ne répond qu'à 15% de leur besoin.
        - Autrement dit, les PA font épargner de l'argent au gouvernement.
        - S'il n'y avait pas de PA, il faudrait engagé 1.3 millions d'aidant à temps complet.

3 Caractéristiques qui influencent la proche aidance (Fleury, 2013)

1. **Genre**
    - Travaux intérieurs, soins personnels, traitements et les soins médicaux et organisation des soins sont plus souvent effectués par des femmes
    - Travaux extérieurs sont plus effectués par des hommes.
    - Les femmes fournissent plus d'heures par semaine, même si les hommes s'impliquent plus qu'avant (surtout post retraite).
2. **Âge**
    - Plus grand nombre de proches aidants ont entre 45 et 54 ans. Cette génération forme 31% des aidants.
    - Si on ajoute l'autre groupe plus important, les 55 à 64 ans, ensemble ils forment 60% des proches aidants.
3. **Lien avec l'aidé**
    - **60%** membres famille proche. (souvent c'est la mère ou belle-mère pcq'elles vivent + lgt que les hommes)
    - **20%** membre famille élargie.
    - **20%** voisin, amis, collègues.

Impacts positifs et négatifs du rôle de proches aidants

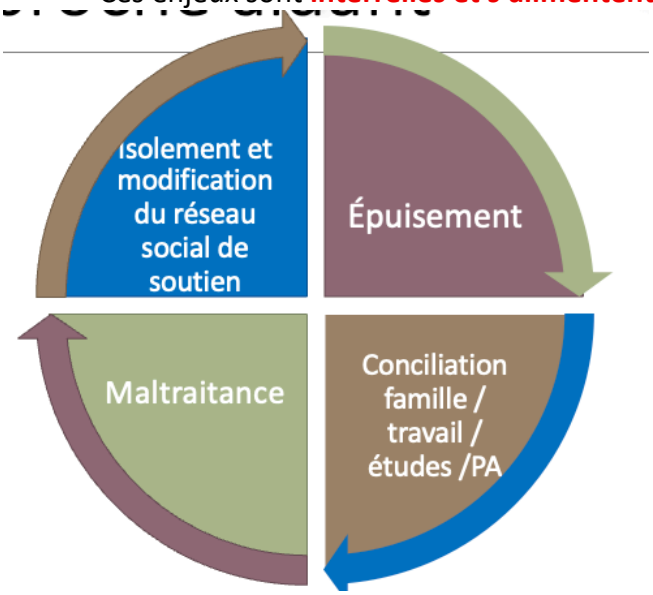
Les impacts du rôle de proche aidant

- **Positifs :**
    - **Sentiment :**
        - d'utilité et d'engagement
        - d'accomplissement
        - de compétence
        - d'empathie, d'intimité et d'amour
        - d'accomplir ses responsabilités
        - de rendre ce qu'on a reçu (réciprocité)
        - d'être apprécié et reconnu
        - d'altruisme
- **Négatifs :**
    - Santé physique (maladies, épuisement, diminution de la résistance immunitaire)
    - Santé mentale (dépression, anxiété)
    - Troubles de sommeil
    - Réduction du temps libre et des activités sociales
    - Conflits familiaux
    - Cumul des rôles
    - Isolement social
    - Conciliation travail/rôle de proche aidant
    - Assumé ce rôle diminue l'espérance de vie de l'aidant de 4-7 ans tellement il est demandant.

- (Chiu et coll., 2010; Holosko et Feit, 2004; Joling et coll., 2010; Pinquart et Sorensen, 2003; Rongve et coll., 2010; Schoenmakers et coll., 2010)

Les enjeux actuels liés au rôle de proche aidant

- **Les nouvelles configuration familiale** font en sorte que le réseau de soutien n'est plus ce qu'il était autrefois ce qui met à risque d'isolement les PA. Cet **isolement** contribue à l'épuisement psycho/physique/moral des PA.
- **La société de performance d'ajd** nous force à devoir performer dans toutes les sphères de notre vie ce qui rend difficile de concilié toutes les responsabilités (famille, travail, études…) et ce surtout lorsqu'on est épuisé.
- **Un des risques du rôle de PA est la maltraitance**, volontaire ou non, provenant de l'aidé, de l'entourage, de la communauté n'offrant que très peu de soutien au PA.
- Ces enjeux sont **interreliés et s'alimentent** les uns les autres.



Questions de réflexions

- **Quelles sont les principales conséquences du rôle de proche aidant selon les capsules vidéos présentées dans ce cours?**
  - Cout financier
  - Impact psycho, physique, moral
  - Épuisement
  - Isolement
  - Aspect + et – (liste plus haut)
  - Moins de cout pour le gouvernement
- **Quelles sont les vôtres si vous êtes proche aidant ?**

Contexte politique et légal entourant la proche aidance

Lois, politiques et plans d'action

- **Loi :**
  - **document légal et juridique**
  - texte qui énonce des règles afin d'organiser la vie en société
  - elle définit des droits et des devoirs

        - si ceux-ci sont transgressés, on peut faire affaire avec les tribunaux qui se chargent d'appliquer la loi afin qu'ils interviennent
    - Les députés de l'assemblé nationale adoptent les lois. Suite à quoi le gouvernement élabore des documents (qui sont désignés comme politique, plan d'action, directives, …) qui ne sont pas légaux (comme les lois) mais servent de guide d'interprétation des lois. C'est souvent des règles internes destinées aux org. gouv. qui sont chargés de prendre des décisions administratives. Autrement dit, ces documents encadrent les tâches des fonctionnaires.
- **Politique :**
    - **découle d'une loi (mais pas tjrs)**
        - parfois on a une politique sans avoir eu de loi précédemment
    - reprend la vision et les grandes orientations de la loi (c'est plus concret que la loi)
- **Plan d'action :**
    - **découle de la politique** encore plus concret que la politique
    - Indique des moyens concrets d'atteindre les objectifs ou orientations de la politique
    - On a des mesures à suivre avec des échéanciers
    - Il couvre 4-5 ans et le gouvernement s'engage à mettre en place des mesures concrètes pour atteindre les orientations de la politique

Projet de loi 56 (2020) – 9 aspects (chronologique)

- L'histoire des services sociaux comment ***dans les années 1960*** lors de la mise en place de l'État providence marqué par la prise en charge institutionnel ('mettre les gens (santé mental, aînés, handicapé) en institutions'). A ce moment, l'état veut dégager les familles de la responsabilités et prendre en charge les membres de la société les plus vulnérables.
- ***Dans les années 70,*** malgré cette politique d'institution, les familles s'occupent encore bcp de leurs proches. Ainsi, l'état s'adapte et met en place la 1ère politique de soutien à domicile en 1979 stipulant l'importance de maintenir les aidés dans leur milieu naturel. Bémol, les PA ne sont pas mentionnés dans cette politique.

1. Politiques sur le vieillissement **(1985, 2012)** & Plan d'action **(2012-2017, 2018-2023)**
2. Politiques de santé mentale **(1989)**
3. Loi modifiant le code des professions **(2002)**
4. Politique de soutien à domicile **(2003)**
5. Politiques soins palliatifs et de fin de vie **(2004, 2010)**
6. Plan Alzheimer **(2009)**
7. Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants **(2009)**
8. Plan stratégique du Curateur public **(2011)**
9. Loi sur les normes du travail **(2018-2019)**

1)Politiques en matière de vieillissement (1985, 2012)

- ***En 1985***, dans la politique sur les pers.âgés ''un nouvel âge à partager' qu'on reconnaît pour la 1ère fois la part des familles dans le bien-être des aidés. On mentionne qu'il faut soutenir les PA si on veut venir en aide aux pers.âgés
    - C'est la 1ere politique à parler des PA, appelé alors 'la famille'.
- ***En 2012***, politique sur le vieillissement mise en place par le gouv. qui est plus global que celle de 1985 sur les pers.âgées.
    - C'est la 2eme politique sur le vieillissement
    - Elle n'est pt pas spécifique aux PA, ceci dit, elle leur fait une petite place.
    - Elle est tjrs en cours ajd.

- 2 plans d'actions (décrivent de façon concrète les actions à prendre pour appliquer une politique) découlent de cette politique :
    - ***2012-2017***
    - ***2018-2023***
        - N'apporte rien d'innovateur dans la section sur les PA en fonction du plan précédent
        - On veut reconnaître et soutenir les PA via 9 mesures (campagnes de sensibilisation, crédit d'impôt, meilleur offre de service)
        - On retire la section sur la conciliation travail et PA présent dans le plan d'action de 2012
- Bilans suivant les 2 plans afin de justifier ce qui a été fait par le gouvernement.

2)Politiques dans le domaine de la santé mentale (1989, 1998, 2005, 2015)

- ***En 1989,*** le gouvernement met en place une politique en santé mentale avec des mises à jour en 1998, en 2005 et en 2015.
    - Politique de 1989 : 1 seul paragraphe touche les PA
- Plans d'actions suivant politiques : 1998-2002, 2005-2010, 2015-2020, 2022-2026
    - ***2022-2026***
        - On parle encore de famille, de membre de l'entourage avec lesquels on doit établir un partenariat et à qui on doit offrir du soutient (comme mentionné dans le précédent plan d'action), mais en rajout on nomme explicitement les jeunes PA.

3)Loi modifiant le code des professionnels (2002)

- Loi 90 qui modifie le code des professions.
- Article 39.6 :
    - 'malgré toutes dispositions inconciliables, un parent, une personne qui assume la garde d'un enfant ou un aidant naturel peut exercer des activités professionnels réserver a un membre d'un ordre'
    - Cela veut dire que depuis l'adoption de la loi 90, les PA peuvent poser des gestes réservés a un professionnel de la santé et il est protégé en cas de problème.
    - On reconnaît dans cette loi que les PA ('aidant naturel' à ce moment-là) posaient déjà des actes professionnel et qu'on a besoin qu'ils puissent le faire. La loi 90 officialise cette responsabilité.

4)Politique de soutien à domicile (2003)

- 2ème politique de soutien à domicile sort en 2003.
    - 1er est en 1979, où on ne parlait pas à ce moment de PA dans la politique.
- On met l'accent pour la 1ere fois sur le rôle essentiel des PA.
    - La politique est fondée sur la reconnaissance de l'engagement PA et des famille qui, il faut le rappeler, fournissent le ¾ de l'aide aux personnes ayant une incapacité (MSSS, 2003, p.3)
- C'est une politique plus inclusive que les autres et met les PA au centre de la politique.
- C'est en 1985, dans une politique de vieillissement + loi 90 avant 2003, qu'on parle pour la 1ere fois de PA (donc pas en 2003).
- Cette politique de 2003 propose que les PA soient des partenaires (aussi présent dans politique en santé mentale) et des clients des services à domicile.
    - Dans les faits, ils seront que des partenaires, car sans eux le soutient à domicile des personnes âgées ne serait pas possible. Aucune place n'est fait pour que les proches aidants soient clients, car on a pas mis place des mesures permettant d'évaluer leurs besoins. En fait, on leur donne plus de pouvoir pour accomplir leur rôle dans l'article 39.6 de la loi 90.

- Donc dans les faits, les PA ont plus de responsabilités dans une perspective partenariale mais sans leur offrir les services dont ils ont besoin à titre de client.

5)Politiques soins palliatifs et de fin de vie (2004, 2010)

- Plan d'action 2015-2020, 2020-2025 et loi 2015.
- QC est pionnier dans le Nord dans les soins palliatifs.
- 1ère politique en 2004 et une 2ème en 2010, soit la même politique avec une date différente.
- Dans les politiques de 2004 et 2010, les PA sont encore appelés les proches et ce mm si on a nommé le terme PA l'année précédente dans la politique de soutien à domicile en 2003.
- On mentionne la nécessité de soutenir les proches et de respecter leurs valeurs, points de vue et besoins dans les décisions
- Dans le plan d'action 2020-2025, le terme PA est utilisé plusiseurs fois & c'est une des priorité du plan d'action de reconnaître et soutenir les PA.

6)Plan Alzheimer (2009)

- 1ère politique en matière d'Alzheimer au QC, prévoit le soutien des PA dans l'action prioritaire n.7 ''les PA, des partenaires à soutenir''. On y mentionne que les PA doivent être accompagné dès l'annonce du dx de la maladie d'Alzheimer de leur proche.
  - Dans les faits, ce n'est pas le cas ajd car on est présentement dans la 2ème phase de ce plan qui a pour objectif la diffusion, l'adoption et l'application des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles sur l'ensemble du territoire QC en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer.
  - Le point d'entrée est la GMF (groupe médecine familiale).
  - Comme il s'agit d'un guide, il est peu question des PA dans cette 2ème phase du plan.

7)Loi instituant le fond de soutien aux PA (2009) ما ى

- Consultation de 2007 sur les conditions de vie des ainées, mène le gouvernement à adopté la loi instituant le fond de soutien aux PA d'ainé visant à créer un fond de 200 000 000$ sur 10 ans.
  - Le gouvernement du Qc verse 150 000 000, soit 15 millions par an durant 10 ans à partir des revenus sur la taxes des produits du tabac. Autrement dit, les fumeurs financent ce fond.
  - Les 50 millions restants, soit 5 millions par an pendant 10 ans, proviennent d'une firme de la famille André et Lucie Chagnon géré par l'organisme ''l'appui pour les PA'' leur offrant des services. Malheureusement, il couvre certains types d'aidant slm soit ceux s'occupant d'un ainé et ceux s'occupant d'un proche avec la maladie d'Alzheimer. Les autres PA ont donc moins accès à certains services de répit.
- C'est la 1ère fois qu'un fond est strictement réservé aux PA.

8)Plan stratégique du Curateur public (2011-2016, 2016-2021) et loi 18 (2022)

- Le Curateur, en 2012, reconnaît l'importance des PA dans la protection des personnes inaptes.
- Le curateur souhaite demeurer le dernier recours pour les personnes en besoin de protection et veut soutenir les familles dans la protection de leur proche.
- 2 juin 2020, durant la pandémie, le gouvernement a fait adopté une loi qui modifie la loi du Curateur public et qui laisse une plus grande place aux PA, soit via la mesure d'assistance (entre autre). Elle est en vigueur le 1er novembre 2022.

9)Loi sur les normes du travail (2018)

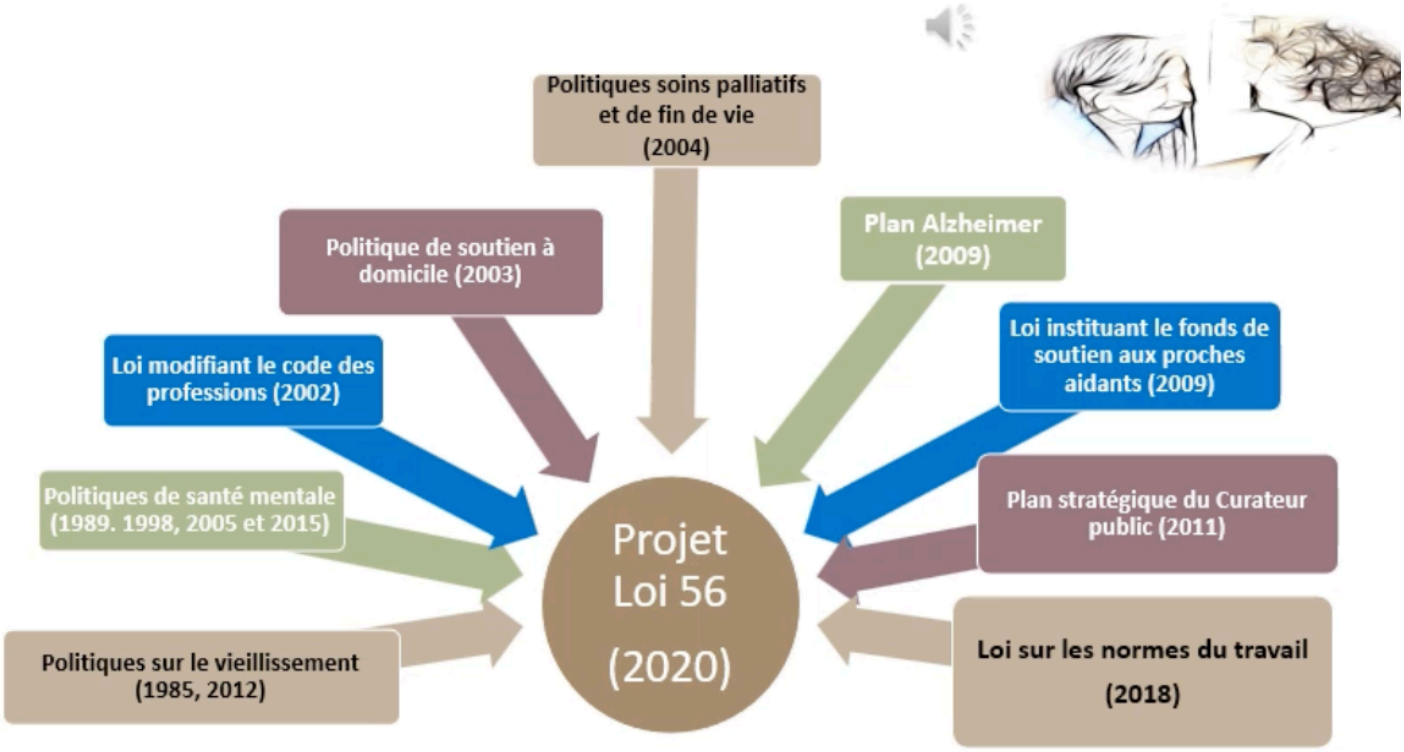
- On reconnaît des droits particulier aux PA qui travaillent, comme des congés.
- Le problèmes est que pour être reconnu PA, il faut une attestation d'un professionnel membre d'un ordre professionnel. Hors ce n'est pas tous les PA qui en côtoie ou vont côtoyer des gens du

communautaire ne faisant pas parti d'un ordre. D'autre part, tous les professionnels d'un ordre ne sont pas habileté à donner cette attestation (ex. médecin vétérinaire, agronomes, architecte, ingénieur,…)

- Qui pourra et devra attester d'une PA, c'est encore peu clair dans la loi.

Conclusion

- Tout ce qui concerne les PA dans les politiques est éparpillés depuis 1985. Cela s'explique car il y a des PA dans toutes les problématiques. L'effet négatif de cela, c'est que les PA d'aînés, personne en fin de vie, avec un trouble de santé mentale ou maladie d'Alzheimer n'ont pas accès aux mêmes services, non pas les mêmes droits car ce sont des politiques différentes qui les concerne et les gouverne.
- Mm si les PA sont nommé dans plusieurs politiques et plan d'action, et nommé explicitement dans 2 loi (loi 6, fond de soutien au PA + loi sur les normes du travail), c'est avec la loi 56 (''projet de loi 56 de Mme Marguerite Blais, ministre responsable des proches aînés et des aidants) qu'on va pour la 1ère fois avoir une loi qui touche directement le domaine de la PA.
- Il était temps qu'on retrouve au même endroit tout ce qui concerne les personnes PA.



Références

Conseil du statut de la femme (mars 2018). Les proches aidantes et les proches aidants au Québec: Analayse différencicée selon le sexe. https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/por_proches_aidants20180419_web.pdf

Ducharme, F. (2012). Prendre soin d'un parent âgé vulnérable, une réflexion sur le concept de « proche aidant » et de ses attributs. Les cahiers de l'année gérontologique, 4(2), 74-78.

Fleury, C. (2013). Portrait des personnes proches aidantes âgées de 45 ans et plus. Coup d'oeil sociodémographique, n° 27, Institut de la statistique du Québec. http://bit.ly/1UH9vmA

Hango, D. (2020). Regards sur la société canadienne. Soutien reçu par les aidants au Canada. Statistiques Canada. No 75-006-X au catalogue. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/75-006-x/2020001/article/00001-fra.pdf?st=fiZaesAb

Holosko M.J. et Feit, M.D. (2004). Social Work Practice with the elderly. 3e édition. Canadian Scholars Press.

Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2012). Répartition des proches aidants âgés de 15 ans et plus selon le nombre de bénéficiaires et le nombre moyen d'heures d'aide fournie chaque semaine, Québec, Canada hors Québec et ensemble du Canada, 2012. http://bit.ly/1QkK3fW

Institut de la Statistique du Québec (ISQ). (2014). Coup d'œil sociodémographique. Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d'aidant. Conditions de Vie, (43). http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/bulletins/coupdoeil-no43.pdf

Kempeneers, M., Battaglini, A., Van Pevenage, I. (2015). Chiffrer les solidarités familiales. Carnet synthèse no. 4. Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions. CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU.

Lecours, C. (2015). Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d'aidant. Coup d'oeil sociodémographique(43), 1-9.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2003). Chez soi : le premier choix : la politique de soutien à domicile. La politique de soutien à domicile. Gouvernement du Québec: Direction des communications.

Sinha, M. (2013). Portrait des aidants familiaux, 2012. Statistique Canada. No 89-652-X au catalogue. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-652-x/89-652-x2013001-fra.pdf?st=G4kAdORV

Bergman, H. (président du comité) (2009). Relever le défi de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées - Une vision centrée sur la personne, l'humanisme et l'excellence. Rapport du comité d'experts en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour la maladie d'Alzheimer. Gouvernement du Québec: ministère de la Santé et des Services Sociaux. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-829-01W.pdf.

Curateur public du Québec (2011). Le plan stratégique 2011-2016. Gouvernement du Québec. https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/plan-strategique-2011-2016.pdf

Curateur public du Québec (2016). Le plan stratégique 2016-2021. Gouvernement du Québec. https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/plan-strategique-2016-2021.pdf

Éditeur officiel du Québec (2002, 14 juin). Loi 90 : Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.

Éditeur officiel du Québec (2009, 27 octobre). Projet de loi no 6: Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants.

Éditeur officiel du Québec (2018) Loi sur les normes du travail.

Éditeur officiel du Québec (2020, 3 juin). Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes.

Éditeur officiel du Québec. (2020, 28 octobre). Projet de loi no 56 : Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives.

Éditeur officiel du Québec. (2020, 3 juin). Projet de loi 18; Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes
Ministère des affaires sociales (MAS) (1985). Un nouvel âge à partager : politique du Ministère des affaires sociales à l'égard des personnes âgées. Gouvernement du Québec.

Ministère de la Famille (MF) (2012). Vieillir et vivre ensemble Chez soi, dans sa communauté, au Québec. Gouvernement du Québec. https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (1989) Politique de santé mentale. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/89-sante-mentale.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2003). Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile, Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-704-01.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2004, 2010). Politique en soins palliatifs de fin de vie. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2004/04-828-02.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2005). Plan d'action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2005/05-914-01.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2015). Plan d'action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-914-17W.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2022). Un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité. Plan d'action 2020-2025. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003444/

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2003). Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile, Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-704-01.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2022). Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003301/

Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille (2018). Un Québec pour tous les âges. Plan d'action 2018-2023. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/F-5234-MSSS-18.pdf